PACIENTE
Roberto Carlos Cartes Jiménez

Datos de demostración
Grupo sanguíneo O+ · Ficha DEMO-TI-2024-0814-01

INFORME MÉDICO

Dolor lumbar mecánico

Evaluación inicial, diagnóstico y plan de manejo conservador.

Fecha: 14-08-2024 · Dr. Andrés Molina · Hospital de Referencia (ejemplo)

Motivo de consulta

Dolor lumbar bajo de tres semanas de evolución, intermitente, relacionado con cargas prolongadas y sedestación. Sin dolor irradiado a la pierna ni pérdida de fuerza.

Antecedentes relevantes

- Sin cirugías previas de columna. Sin traumatismo reciente.
- Sin fiebre, pérdida de peso ni síntomas sistémicos.
- Actividad física irregular en los últimos meses.

Hallazgos

- Dolor a la palpación de musculatura paravertebral lumbar baja, sin contractura intensa.
- Movilidad lumbar: flexión 60°, extensión 20°, inclinaciones simétricas.
- Fuerza 5/5 en ambos miembros inferiores; reflejos rotulianos y aquíleos conservados.
- Lasègue negativo bilateral. Sensibilidad conservada. Sin signos de alarma.

Diagnóstico e impresión clínica

Diagnóstico de ejemplo
Lumbalgia mecánica sin signos de compromiso radicular. Cuadro de origen postural, sin evidencia clínica de hernia aguda ni infección.

CÓDIGO CIE-10 M54.5 ESPECIALIDAD Traumatología

Plan y recomendaciones

- Kinesiología: educación, movilidad y fortalecimiento progresivo.
- Paracetamol 500 mg cada 8 horas si hay dolor; máximo 3 g al día.
- Ibuprofeno 400 mg cada 8 horas con alimentos, solo si el dolor lo requiere.
- Evitar reposo prolongado; caminar y mantener actividad tolerada.
- Control en 4 semanas o antes si aparece dolor irradiado o déficit de fuerza.

Signos de alarma
Consultar de inmediato si aparece pérdida de fuerza, anestesia en silla de montar, alteración para orinar o defecar, fiebre o dolor nocturno progresivo.

Dr. Andrés Molina
Traumatología · documento de ejemplo
Documento de ejemplo

SIN VALOR CLÍNICO